

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE VISITA DOMICILIARIA

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TECNICO SUPERIOR DE ENFERMERIA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VISITA DOMICILIARIA
CURSO	PMS4111	N° ACTIVIDAD	3
ASIGNATURA	PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	DURACIÓN	80 MINUTOS
FECHA		N° DE ALUMNOS	10 a 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Aplicar las fases de la Visita Domiciliaria Integral (VDI) en el caso clínico a desarrollar en un ambiente simulado a través de una aplicación estructurada y adaptada a las necesidades del paciente • Identificar factores protectores y de riesgo en pacientes con dependencia severa en la Visita Domiciliaria Integral (VDI) en el caso clínico. • Aplicar técnicas propias del rol de Técnico en Enfermería derivadas de la promoción y prevención en salud, aplicándolas en el manejo del paciente en contexto domiciliario dentro del caso clínico simulado.			

3: INTRODUCCIÓN

La visita domiciliaria es una estrategia clave en la atención primaria de salud que permite el acceso a cuidados de calidad para pacientes con movilidad reducida, enfermedades crónicas o en situaciones de vulnerabilidad. Su implementación no sólo favorece la continuidad del tratamiento y la prevención de complicaciones, sino que también optimiza los recursos del sistema sanitario, reduciendo la demanda hospitalaria y fortaleciendo la relación entre el equipo de salud y la comunidad.

En Chile los datos epidemiológicos recientes reflejan el impacto de las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión en la población, lo que ha generado una mayor necesidad de atención domiciliaria. Asimismo, el envejecimiento demográfico y el aumento de patologías de larga duración han posicionado este modelo de atención como una herramienta esencial en el sistema de salud.

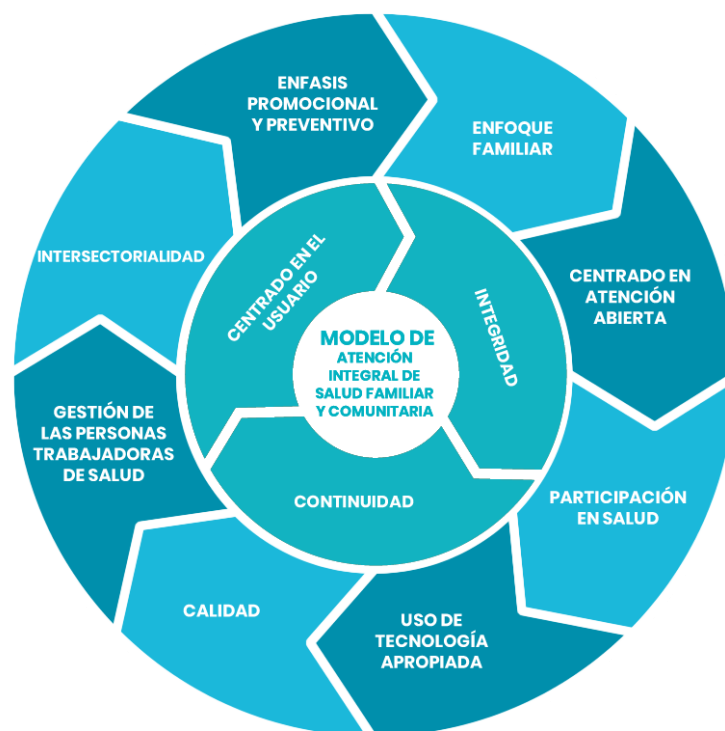
El modelo de visita domiciliaria contribuye significativamente a la descongestión de los centros de salud, optimizando los recursos hospitalarios y mejorando la gestión del sistema sanitario. La labor del Técnico en Enfermería en este ámbito no solo beneficia la calidad de vida de los pacientes, sino que también fortalece la implementación de estrategias preventivas y promueve un enfoque más humanizado en la atención de salud.

4: DESARROLLO DEL TEMA

Definición y Marco Conceptual

La visita domiciliaria se define como un servicio de atención en salud que permite llevar cuidados médicos y de enfermería directamente al hogar de los pacientes. Se basa en el **Modelo de Atención**

Integral de Salud Familiar y Comunitaria, priorizando un enfoque centrado en el paciente, con intervenciones adaptadas a sus necesidades individuales y a su entorno.



Fuente: <https://salud.municipalidadrengo.cl/salud-comunal/politica-de-salud/>

Importancia de la Atención Domiciliaria

La atención domiciliaria juega un rol crucial en la prevención, tratamiento y seguimiento de enfermedades crónicas. Más allá de garantizar el acceso a cuidados de calidad, este modelo permite mejorar la adherencia terapéutica, evitar complicaciones derivadas de la falta de supervisión médica y disminuir el número de hospitalizaciones innecesarias. Su aplicación también favorece el desarrollo de estrategias preventivas, promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo el compromiso de los pacientes y sus familias en el proceso de recuperación.

Tipos de Visita Domiciliaria Integral (VDI)

1. **Visita Domiciliaria Integral de Primer Contacto:** Se realiza por primera vez en el hogar, estableciendo el vínculo con la familia, complementando diagnósticos y planificando futuras intervenciones junto con el grupo familiar.
2. **Visita Domiciliaria Integral de Seguimiento:** Se ejecuta como parte de un plan de intervención familiar, asegurando el monitoreo y continuidad de los cuidados según riesgos detectados.

Recomendaciones para una VDI Efectiva

- Debe ser realizada por equipos multidisciplinarios entrenados en comunicación, cuidado centrado en la persona y salud participativa.

- Las visitas deben tener objetivos claros, ser medibles y contar con registros precisos para garantizar la continuidad del cuidado.
- Se recomienda apoyo telefónico para consultas y monitoreo constante del desempeño profesional y resultados obtenidos.

Fases de la Visita Domiciliaria

Fase Inicial: en esta primera parte se crea el vínculo con la familia, se realiza la presentación del equipo y se establece un clima de confianza.

Se inicia con la llegada al hogar y el contacto inicial, que incluye saludo y presentación con identificación, además en esta fase:

- Se pregunta por la persona con la cual se hizo el contacto y se acordó la visita.
- Se realiza un recuerdo breve de por qué se está allí.
- Un tema central en esta llegada es el clima de apertura, respeto, autenticidad e interés hacia la persona tal cual es.

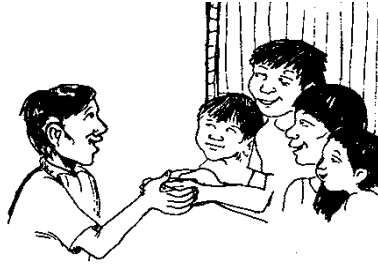


Fase de Desarrollo: se observa el entorno físico y social, identificación de dinámicas familiares, permite una observación más profunda del entorno.

Es la fase de detección de necesidades prioritarias del paciente que incluyen el seguimiento de enfermedades crónicas, el apoyo en la administración de medicamentos, la educación en autocuidado, la prevención de complicaciones y la promoción de la salud. La atención domiciliaria busca garantizar un enfoque integral, considerando no sólo la condición médica del paciente, sino también su bienestar emocional y social.



Fase de Cierre: además de la síntesis de acuerdos, la despedida empática y la retroalimentación entre los profesionales, el **Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS)** cumple un rol fundamental en el acompañamiento emocional, brindando apoyo al paciente y su familia en el cierre de la intervención.



Registro y Seguimiento: Una vez finalizada la visita, el equipo debe documentar los hallazgos y acciones en la ficha individual o familiar para asegurar la trazabilidad de la intervención.



El Rol del Técnico en Enfermería en VDI

El Técnico en Enfermería desempeña un papel fundamental en la visita domiciliaria, contribuyendo activamente al bienestar de los pacientes mediante cuidados especializados. Entre sus principales funciones se encuentran:

- **Evaluación del paciente en el hogar:** Identificación de necesidades y elaboración de un plan de cuidados personalizado.
- **Administración de tratamientos:** Aplicación de medicamentos, curaciones y otras intervenciones terapéuticas bajo supervisión profesional.
- **Monitoreo de signos vitales:** Control de parámetros como presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno.
- **Educación sanitaria:** Orientación al paciente y su familia sobre autocuidado, prevención de enfermedades y cumplimiento del tratamiento.
- **Apoyo emocional y social:** Interacción cercana con los pacientes, promoviendo confianza y bienestar en el proceso de recuperación.
- **Coordinación con el equipo de salud:** Comunicación efectiva con médicos y enfermeros para garantizar una atención integral.

PROGRAMACIÓN Y PREPARACION DE LA VISITA DOMICILIARIA:

Descripción	Imagen referencia	Justificación
Llamar al paciente o cuidador principal		Permite confirmar la disponibilidad del paciente y su familia, asegurando que la visita se realice en un momento adecuado.
Indicar su nombre y rol como técnico de enfermería		Establece un vínculo de seguridad y cercanía con el paciente y su familia, facilitando la comunicación.
Explicar el propósito de la visita, entregando los objetivos y lo que realizara		Se prepara a la familia o cuidador del paciente, asegurando que la visita se desarrolle de manera óptima.
Preguntar sobre la situación y necesidad actual del paciente		Permite que el equipo de salud planifique adecuadamente la visita, evitando desplazamientos innecesarios.
Acodar el día y hora para la VDI		Se asegura una comunicación clara y comprensible para el familiar o cuidador
Utilizar un tono empático y respetuoso		Se garantiza un enfoque integral y personalizado en su cuidado, durante la visita
Planificar de acuerdo con antecedentes médicos en ficha de paciente y datos entregados por paciente, familia o cuidador.		
Preparar el maletín de visita domiciliaria, con todo el equipo e insumos necesarios según la planificación de la visita		Contar en la visita domiciliaria con los equipos e insumos adecuados para la atención del paciente

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL DEL TENS

Descripción	Imagen referencia	Justificación
Llegar día y hora acordada con la familia o cuidadora		La puntualidad demuestra compromiso y respeto
FASE DE INICIO		
Indicar su nombre y rol como Técnico en Enfermería (TENS).		Establece un vínculo de seguridad y cercanía con el paciente y su familia, facilitando la comunicación
Explicar nuevamente el propósito de la visita,		Permite reforzar la información

describiendo brevemente los objetivos y el tipo de apoyo que se brindará.		proporcionada previamente por vía telefónica
Consultar nuevamente sobre el estado de salud actual de la paciente, brindando al cuidador la oportunidad de expresar sus inquietudes y necesidades durante la visita domiciliaria.		Permite que el cuidador exprese sus inquietudes o necesidades que no había mencionado en el llamado telefónico
Utiliza un tono empático y respetuoso, asegurando una comunicación clara y comprensible para el familiar.		Un tono cercano y comprensible permite que el paciente y sus familiares se sientan escuchados y valorados
FASE DE DESARROLLO		
Solicitar permiso para realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
Realizar acciones de enfermería de acuerdo con lo programado: <u>EVALUACION</u> • Evaluación del entorno domiciliario para detectar condiciones que puedan afectar la salud del paciente • Valoración del estado de salud del paciente • Control de signos vitales (PA, FR, FC, Tº, SAT) • Identificación de factores de riesgo y necesidades <u>PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA</u> • Administración de medicamentos según indicaciones médicas.	 	Realizar los puntos en el Rol del TENS de la fase de desarrollo de la visita domiciliaria es clave para garantizar una atención integral, estructurada y centrada en el bienestar del paciente y su entorno.

- Curaciones de heridas y manejo de lesiones por presión.
- Aplicación de inyecciones y vacunas.
- Control de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
- Manejo de dispositivos médicos (sondas, catéteres, oxigenoterapia, etc.).



EDUCACION Y ORIENTACION

- Capacitación al paciente y su familia sobre el autocuidado.
- Instrucción sobre la correcta administración de medicamentos.
- Orientación sobre hábitos saludables y prevención de enfermedades.
- Asesoramiento sobre alimentación y nutrición adecuada.

APOYO PSICOSOCIAL

- Acompañamiento emocional al paciente y su familia.
- Identificación de signos de depresión o ansiedad.
- Coordinación con otros profesionales de salud si se requiere apoyo psicológico o social.

FASE DE CIERRE

• Sintetiza y verifica con la familia los acuerdos establecidos, asegurando claridad en los compromisos. • Se despide de cada integrante de la familia con respeto y calidez. Expresando agradecimiento por la apertura y colaboración durante la visita. REGISTRO Y COORDINACIÓN • Documentación de la evolución del paciente. • Coordinación con otros profesionales de salud para garantizar la continuidad del tratamiento. • Derivación a servicios especializados si es necesario.		Realizar esta fase garantiza una atención completa y fortalece la relación entre el equipo de salud, el paciente y su familia Realizar el registro y coordinación es una acción clave para garantizar la continuidad y calidad de la atención
---	---	---

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y Control de Enfermedades - Departamento de Ciclo Vital; Subsecretaría de Redes Asistenciales, División de Atención Primaria - Departamento Modelo Atención Primaria. Visita Domiciliaria Integral: Orientaciones Técnicas en el Marco del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria [Internet]. Santiago: Ministerio de Salud de Chile; 2018 [citado el 1 de mayo de 2025]. Disponible en: https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/06/2018.04.17_OT-VISITA-DOMICILIARIA-INTEGRAL.pdf
2. Servicio de Salud Coquimbo. Programa de visitas domiciliarias integrales a desmovilizados [Internet]. Coquimbo: Servicio de Salud Coquimbo; 2017 [citado el 15 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.sccoquimbo.cl/gob-cl/mais/files/06-12-2017/atencion/PROGRAMADE%20VISITAS%20%20DOMICIALIARIAS%20INTEGRALES%20A%20DISMOVILIZADOS%20To.pdf>
3. Glasinovic A, Canessa J, Sancy D, Sotomayor F. Buenas prácticas en la visita domiciliaria integral en atención primaria chilena [Internet]. Santiago: Revista Médica Clínica Las

Condes; 2021 [citado el 15 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/en-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-buenas-practicas-visita-domiciliaria-integral-S0716864021000663>

4. Rodríguez Cerda R. Enfermería y la visita domiciliaria [Internet]. Ocronos - Revista Médica y de Enfermería; 2020 [citado el 15 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://revistamedica.com/enfermeria-visita-domiciliaria/>